

CHAMP 1 PÉRI-OPÉRATOIRE

RISQUE
NUTRITIONNEL

FACTEURS DE RISQUE *

- **Liés au patient:**
Âge, cancer, sepsis, pathologie chronique, antécédents chirurgicaux majeurs, troubles neurologiques ou psychiatriques, Symptômes digestifs chroniques
- **Liés au traitement:**
Chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, polymédication

SCORES *



Score GNRI

(Geriatric Nutritional Risk Index)

Score CONUT

(Controlling Nutritional Status score)

DIAGNOSTIC DE LA DÉNUTRITION

1 CRITÈRE PHÉNOTYPIQUE HAS †



- Calcul de la **perte de poids pré-opératoire** :
→ Anamnèse : $\geq 5\%$ /1 mois **ou** $\geq 10\%$ /6 mois **ou** $\geq 10\%$ /poids habituel avant maladie
- **IMC** : $< 18.5 \text{ kg/m}^2$ si < 70 ans / $< 22 \text{ kg/m}^2$ si ≥ 70 ans
- **Réduction de la force** : Force de préhension et/ou test de levers de chaise
- **Réduction de la masse musculaire** (si disponible : imagerie, impédancemétrie, DEXA)

+

1 CRITÈRE ÉTIOLOGIQUE HAS †



- **Réduction de la prise alimentaire**
- **Malabsorption / maldigestion**
- **Situation d'agression** :
Chirurgie à risque intermédiaire ou élevé, ou contexte carcinologique

POUR POSER LE
DIAGNOSTIC DE LA
DÉNUTRITION

=

1 seul critère
phénotypique

+

1 seul critère
étiologique

Suffisent parmi
tous ceux listés

SÉVÉRITÉ ET SUIVI



ALBUMINÉMIE

- Sévérité de la dénutrition

Modérée : 30-35 g/L
 Sévère : ≤ 30 g/L
- Valeur pronostique

PRÉ-ALBUMINÉMIE

- Suivi dynamique de l'état nutritionnel

CHAMP 1 PÉRI-OPÉRATOIRE

STRATÉGIES PRÉ-OPÉRATOIRES

PRÉHABILITATION

Stratifiée sur risque individuel :

- Fragilité / Réserve fonctionnelle diminuée
- Dénutrition avérée / Sarcopénie
- Score ASA ≥ 3 / Âge $\geq 65-70$ ans

Exercice physique

Équilibration comorbidités

Stratégie nutritionnelle

STRATÉGIE NUTRITIONNELLE

Nutrition artificielle pré-opératoire

Anticipation de la reprise alimentaire post-opératoire

STRATÉGIES POST-OPÉRATOIRES

RAAC

Stratégie de réhabilitation améliorée
incluant une stratégie nutritionnelle

STRATÉGIE NUTRITIONNELLE

Reprise alimentaire précoce orale ou artificielle
+/- combinaison des voies nutritionnelles pour
atteindre les cibles

Cibles : 20-25 kcal/kg/j et 1-1.3 g de protéines/kg/j

INTÉGRATION PRÉCOCE DU DIÉTÉTICIEN ET DURANT L'ENSEMBLE DU PARCOURS PÉRI-OPÉRATOIRE

Limitation de la perte
de poids

Atteinte optimisée des
cibles caloriques et
protéiques

Meilleure application des
recommandations

Meilleure valorisation
financière des séjours

CHAMP 2 - SOINS CRITIQUES

RISQUE
NUTRITIONNEL

PAS DE SCORE
SPÉCIFIQUE



Tout patient admis en
soins critiques est à
risque nutritionnel

DIAGNOSTIC DE LA DÉNUTRITION

1 CRITÈRE PHÉNOTYPIQUE HAS *



- Calcul de la **perte de poids avant admission**
→ Anamnèse : $\geq 5\%$ /1 mois **ou** $\geq 10\%$ /6 mois **ou**
 $\geq 10\%$ /poids habituel avant maladie
- **IMC** : $<18.5 \text{ kg/m}^2$ si <70 ans / $<22 \text{ kg/m}^2$ si ≥ 70 ans
- **Réduction de la force** (si réalisable)
- **Réduction de la masse musculaire**

+

1 CRITÈRE ÉTIOLOGIQUE HAS *



- **Réduction de la prise alimentaire**
- **Malabsorption / maldigestion**
- **Situation d'agression** : Pathologie aiguë critique

POUR POSER LE
DIAGNOSTIC DE LA
DÉNUTRITION

=

1 seul critère
phénotypique

+

1 seul critère
étiologique

Suffisent parmi
tous ceux listés

SÉVÉRITÉ ET SUIVI

BIOLOGIE

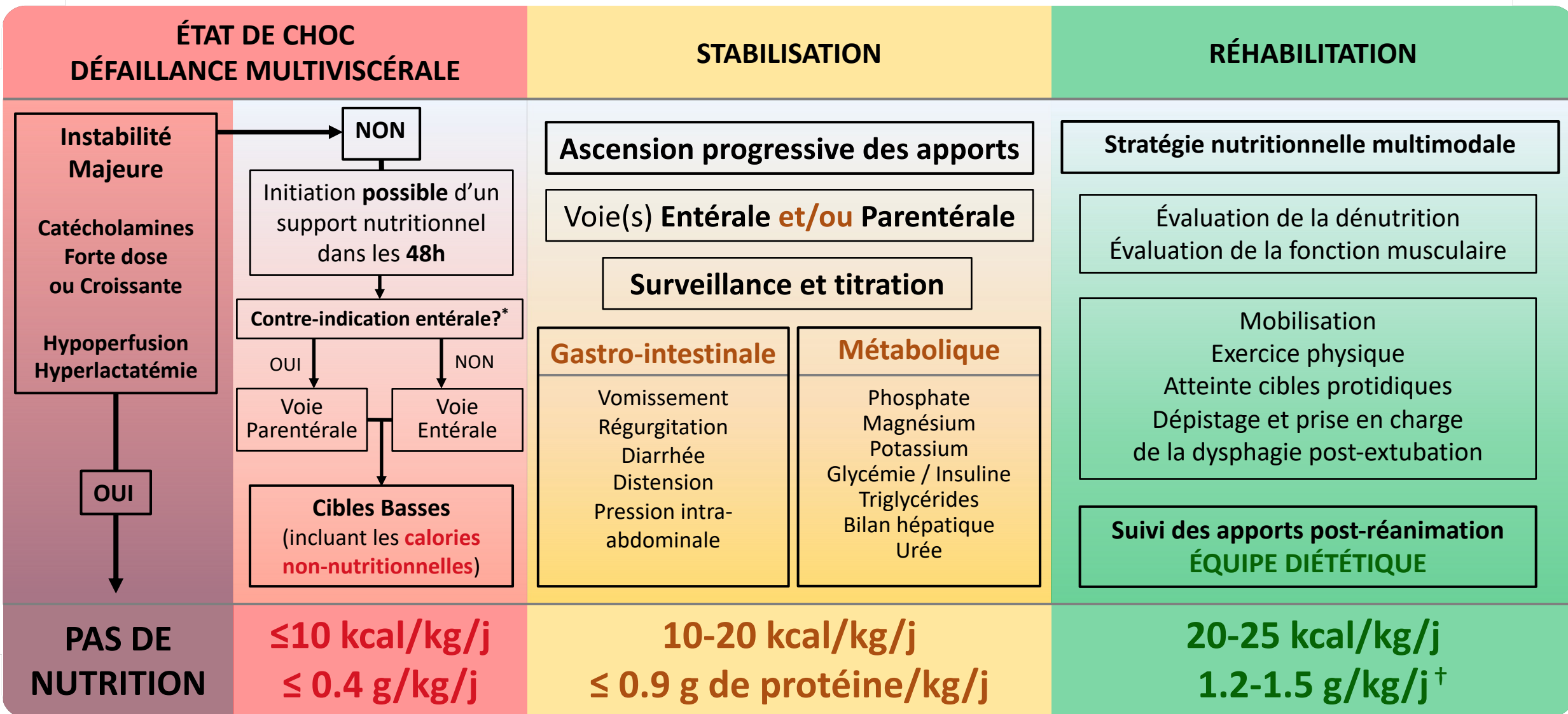


ALBUMINÉMIE

- Sévérité de la dénutrition
 - Modérée : 30-35 g/L
 - Sévère : ≤ 30 g/L
- Valeur pronostique

mNUTRIC

- Stratification du risque



* Hémorragie digestive haute non contrôlée, ischémie intestinale suspectée ou avérée, occlusion intestinale, syndrome du compartiment abdominal, fistule digestive à haut débit en l'absence d'accès distal.

† Chez les patients en phase de réhabilitation présentant une insuffisance rénale aiguë sans épuration extra-rénale, il est recommandé de maintenir une cible protéique modérée de 0.9 g/kg/j.

CHAMP 2 - SOINS CRITIQUES



Propofol 1% 150 mg/h (15 mL/h)

≈ 400 kcal/24h

(NB: Apports divisés par 2 avec Propofol 2% (200 kcal/24h))



Soluté glucosé à 5% (G5%) 500 mL/j

= 100 kcal/24h



Épuration extra-rénale au citrate

≈ 200 kcal/24h

$$E_{\text{citrate}} \text{ (kcal/j)} = Q_{\text{sang}} \text{ (mL/min)} \times D_{\text{citrate}} \text{ (mmol/L de sang)} \times \frac{60 \times 24}{1000} \times \left(1 - \frac{F_{\text{élimination}}}{100}\right) \times 0,59 \text{ (kcal/mmol)}$$

1 g glucose = 4 kcal
1 mL propofol = 1.1 kcal
1 g citrate ≈ 3 kcal

700 kcal/24h
≈ 10 kcal/kg/24h
pour un patient de 70 kg



Afin d'éviter tout risque de surnutrition, les **calories non nutritionnelles doivent être intégrées** dans l'évaluation des apports énergétiques avant d'initier ou d'augmenter le support nutritionnel. Lorsque ces apports dépassent les cibles adaptées à l'état clinique du patient, l'instauration du support nutritionnel doit être **différée**.

CHAMP 2 - SOINS CRITIQUES



**INTOLÉRANCE
DIGESTIVE
HAUTE**

①

Prokinétiques

Durant 48-72 h

Erythromycine (100-250 mg x 3/j IVL)

Métoclopramide (10 mg x 3/j IVL)

②

**Échec
Prokinétiques**

Nutrition entérale post-pylorique / jéjunale

Nutrition entérale intermittente non recommandée



DIARRHÉE

Solutés entéraux contenant des fibres



**CONSTIPATION
DISTENSION
ABDOMINALE**

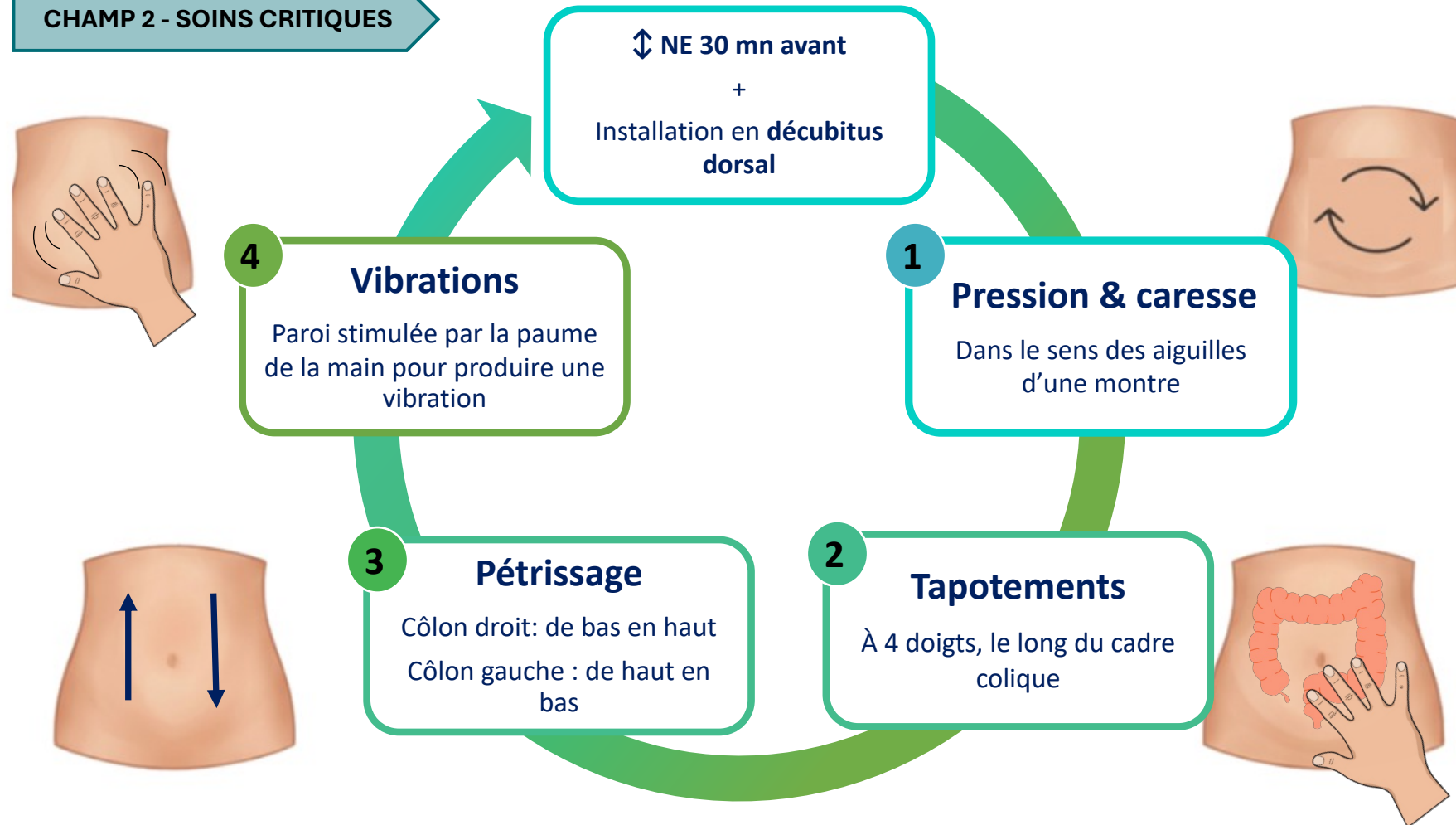
Solutés entéraux contenant des fibres

Laxatifs curatifs (utilisation prophylactique non recommandée)

Massages abdominaux protocolisés

PAMORAs non recommandés (prophylactiques ou curatifs)

CHAMP 2 - SOINS CRITIQUES



Matin et soir

Durée totale = 15 min
(installation +
3 min/étape)

3 jours consécutifs

Personnel paramédical formé
(IDE / AS)

En l'absence de contre-
indication *

CHAMP 2 - SOINS CRITIQUES



SURVEILLANCE : suivre régulièrement la tolérance et l'efficacité du support nutritionnel pour adapter la prise en charge et prévenir les complications

TOLÉRANCE

CLINIQUE



GIDS

Recueil VRG
non recommandé

MÉTABOLIQUE



Si NP et/ou dose
élevée de propofol :
BH x 2/semaine
TG x 1/semaine

Dépistage SRI
[K, Ph, Mg] x 1/jour
jusqu'à J3-J5

EFFICACITÉ

COURT TERME



Pesée régulière

Préalbumine
x 1/semaine

Monitoring par
calorimétrie indirecte?

MOYEN TERME



Masse musculaire
(imagerie,
impédancemétrie, DEXA)

LONG TERME



Tests fonctionnels



OBJECTIF : Prévenir la dénutrition, détecter précocement les complications et optimiser les résultats cliniques



CHAMP 2 - SOINS CRITIQUES



Ensemble des manifestations cliniques et biologiques liées à des troubles hydroélectrolytiques et vitaminiques survenant lors de la reprise nutritionnelle après une période de dénutrition ou de jeûne prolongé

TROUBLES HYDROÉLECTROLYTIQUES

Hypophosphatémie
Hypokaliémie
Hypomagnésémie
(Hypovitaminose B1) *

MANIFESTATION CLINIQUES

Cardio-respiratoires (arythmie, anasarque, insuffisance cardiaque gauche, insuffisance respiratoire aiguë)
Neurologiques (encéphalopathie, convulsion)
Musculaires (paresthésies, rhabdomyolyse)
Hématologiques (pancytopénie, hémolyse)

FACTEURS DE RISQUE

- IMC < 18.5 kg/m²
- Perte de poids récente (5-10%)
- Diminution des ingesta (> 50-75%) ou jeûne prolongé
- HypoK, HypoPh, HypoMg
- Maladie chronique (cancer, OH chronique, malabsorption, maladie neurodégénérative, anorexie)
- Polymédication†

PREVENTION

- Initiation ≈ 10 kcal/kg/j
- ↗ progressive sur 7 à 10 jours, par palier (25%), selon tolérance (surveillance lono + ECG/j)
- Thiamine 200-300 mg/j
- Correction des troubles ioniques avant initiation de la nutrition
- Micronutriments (dose journalière)



↗ 10-20% Ph, K, Mg
↗ > 0.16 mmol/L Ph

INTERVENTION

- ↗ apports ou arrêt 24-48 h
- Supplémentation IV et surveillance quotidienne
- Puis reprise lentement progressive



ECG : électrocardiogramme; IMC: Indice de Masse corporelle ; lono : ionogramme plasmatique; IV: intraveineux; K, kaliémie; Mg :Magnésémie; OH: alcool; Ph :phosphatémie. * Dosage vitamine B1 non obligatoire pour diagnostiquer un SRI.

† Traitements favorisant les troubles hydroélectrolytiques : diurétiques, inhibiteur de la pompe à protons, reprise ou instauration d'insuline